

Endométriose

Généralités:

- **Maladie inflammatoire chronique œstrogéno-dépendante.**
- Se définit par la présence de tissu endométrial (**épithélium ± stroma**) en dehors de la cavité utérine.
- Concerne surtout la femme en âge de procréer.
- **Prévalence** : Au moins **190 millions** de femmes et adolescentes dans le monde.

⚙️ Approfondissement Physiopathologique :

- **Pourquoi "Œstrogéno-dépendante" ?** Les lésions d'endométriose expriment des récepteurs aux œstrogènes (ER). Sous l'effet de l'œstradiol, ce tissu ectopique prolifère. De plus, ces lésions possèdent souvent une activité **aromatase** locale, leur permettant de synthétiser leurs propres œstrogènes à partir des androgènes circulants (autocrinie).
- **Pourquoi "Inflammatoire" ?** Le tissu ectopique saigne lors des règles mais le sang ne peut s'extérioriser. Cela induit une réaction inflammatoire locale (production de cytokines, prostaglandines, chimiokines) responsable de la douleur et de la formation d'adhérences.
- **Symptômes majeurs** : Douleur **et/ou** Infertilité **et/ou** Saignement utérin anormal.
- **Retentissement Qualité de Vie** : Impact psycho-social, professionnel, conjugal et familial.
- **Retard Diagnostic** : Moyenne de **7 ans**.

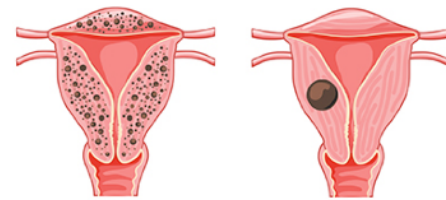
Classification:

Il existe une association fréquente (mais pas obligatoire) entre les deux entités suivantes :

L'Endométriose Interne : Adénomyose

Lésions se développent à l'intérieur même du muscle utérin
Invagination du tissu endométrial dans le myomètre:

- **Diffuse**: fréquente, même chez les femmes jeunes
- **Locale**: adénomyome.
 - **Adénomyome interne**: passage de l'endomètre vers le muscle.
 - **Adénomyome externe**: Les lésions ne proviennent pas de la cavité utérine, mais de cellules d'endométriose externes (péritonéales) qui infiltrant la séreuse utérine (la paroi externe) puis le muscle.



Diffuse adenomyosis

Adenomyoma

L'Endométriose Externe

Localisation en dehors de l'utérus. On distingue :

- **Endométriose superficielle** : Implants superficiels du péritoine.
- **Endométriose Ovarienne** : Endométriome.
- **Endométriose Profonde Sous-Péritonéale (EPSP / DIE)** :
 - Définition : Infiltration **> 5 mm** du péritoine ou atteinte musculuse de l'organe cible.
- **Autres localisations** : Pariétale (sur cicatrice de chirurgie, ombilic), Pulmonaire...

Épidémiologie:

Prévalence (Chiffres Clés)

- **15 %** des femmes en période d'activité génitale (probablement sous-estimé).
- **2-10 %** de la population générale.
- **40 %** des femmes endométriosiques sont hypofertiles.
- **50 %** des femmes infertiles sont endométriosiques.
- **1/3** des algies pelviennes chroniques sont dues à l'endométriose.

- **Comparaison** : Prévalence comparable voire supérieure au diabète.

Délais de Diagnostic

- En cas de douleur (DLR) : **7 ans**.
- En cas d'infertilité : **3 ans**.

Facteurs de Risque

- **Exposition importante aux menstruations (+++)** :
 - Malformation obstructive.
 - Règles précoces.
 - Cycles courts.
 - Règles abondantes.
 - Nulliparité.
- **Hérédité** : 50% des cas (multigénique).
- **Environnement** : Perturbateurs endocriniens.
- **Terrain** : Pathologie inflammatoire et immunitaire.

Physiopathologie:

C'est une "maladie des théories".

Les Théories:

- Théorie métaplasique.
- Théorie d'induction.
- Théorie immunitaire.
- Métastases lymphatiques et vasculaires.
- Théorie mécanique
- **Reflux menstruel par les trompes (Théorie de Sampson)** : Considéré comme le *primum movens*.

Mécanisme de l'Adénomyose (La théorie la plus séduisante)

- **Origine** : Contraintes mécaniques.
- **Processus** :
 1. **Hyper-péristaltisme** (Phase folliculaire) : Les ondes de contractions ascendantes deviennent trop fréquentes ou trop puissantes.
Dys-contractilité (Phase menstruelle) : Le myomètre interne (archimyomètre) subit des pressions anormales et anarchiques.
 2. Ces contraintes mécaniques répétées créent des micro-fissures à l'interface entre l'endomètre basal et le muscle.
 => C'est le stade des **micro-traumatismes** répétés
 3. **Un autotraumatisme répété** entraînant l'irruption des cellules endométriales dans l'archimyomètre.
 4. **Migration cellulaire** : Profitant des brèches dans le muscle, les cellules de la couche basale de l'endomètre s'invaginent (s'enfoncent) à l'intérieur de l'archimyomètre.
 5. **Réparation tissulaire (TIAR)** : Le corps tente de réparer ces micro-lésions, ce qui entretient une inflammation locale et une production d'œstrogènes in situ
- **Timing** : Physiologique après 40 ans, mais possible dès l'adolescence si raisons hormonales complexes (surtout **Hyperœstrogénie**).

Mécanisme de l'Endométriose Externe:

- **Point de départ :** Le reflux menstruel rétrograde (présent physiologiquement chez 90% des femmes).
Une partie du sang et des fragments d'endomètre remonte par les trompes de Fallope pour se déverser dans la cavité péritonéale
- Le paradoxe : Presque toutes les femmes ont ce reflux, mais seules 10 % développent une endométriose. Le reflux est donc nécessaire, mais pas suffisant
- **Pourquoi la maladie se développe ?** Combinaison de facteurs :
 - Génétique / Épigénétique.
 - Immunité défaillante (baisse de l'élimination des cellules).
 - Nutrition.
 - **Facteurs hormonaux :** Hyperœstrogénie + **Résistance à la progestérone.**
- **Conséquence :** Greffe endométriale extra-utérine.

Devenir de l'Endomètre Ectopique:

- Il croît sous l'influence des œstrogènes.
- Il tente de se décidualiser en 2ème partie de cycle.
- **Problème :** La réaction est imparfaite (vascularisation insuffisante, isolement inflammatoire).
- **Évolution :**
 - Aggravation habituelle mais non obligatoire.
 - Parfois régression (nécrose du pédicule vasculaire remplacée par une cicatrice fibreuse).
 - **Risque de la fibrose :** Peut évoluer pour son propre compte et enserrer l'uretère ou le hile ovarien (rétraction).
- **Guérison spontanée :** Possible par la grossesse ou la ménopause.

Anatomopathologie:

Adénomyose

- Petites glandes endométriales kystiques entourées d'une couronne de stroma, contenu séro-hématique.
- **Réaction musculaire :** Hypertrophie des fibres musculaires lisses du myomètre secondaire aux phénomènes inflammatoires cataméniaux.

Endométriose Externe

- **Superficielle :** Implants péritonéaux.
- **Ovarienne :** Endométriome.
- **Profonde (EPSP) :** Située > 5 mm sous le péritoine ou atteinte musculuse de l'organe cible.

Clinique:

Pathologies courantes mais grand retard diagnostique. Le diagnostic repose sur le binôme

Clinique + Radiologie.

Interrogatoire:

- **Âge :** > 20-30 ans, voire avant.

Douleur:

- **Mécanisme de la douleur:**

- **Activation inflammatoire locale:** Les enzymes et les cellules immunitaires (comme les mastocytes) s'activent au sein des lésions d'endométriose.
- **Sécrétion de médiateurs chimiques (prostaglandines PG)** et l'activation de leurs récepteurs spécifiques.
- **Neuro-angiogénèse périphérique:** Les PG stimulent la création de nouveaux vaisseaux et de nouvelles fibres nerveuses directement autour et dans les lésions.
- La répétition des signaux douloureux entraîne une modification chronique au niveau du SNC.
- **Sensibilisation centrale (Central sensitization):** Le système nerveux devient hypersensible, amplifiant le signal de la douleur même en l'absence de nouveau stimulus.

- **Plainte principale : DOULEUR +++** à caractère **Cataménial** (rythmée par les règles).
- **Caractéristiques de la douleur :**
 - Antalgiques simples inefficaces.
 - Retentissement socio-professionnel (absentéisme scolaire/pro) et conjugal.
 - **Disparition de la douleur sous Contraception Oestro-Progestative (COP).**
 - **Pas de corrélation** entre l'intensité de la douleur et la sévérité des lésions.

Les "5 D" (Types de douleurs et signes localisateurs)

1. **Dysménorrhée :**
 - Tardive (2e–3e jour).
 - Secondaire.
 - Souvent associée à des ménorragies (signe d'**Adénomyose**).
2. **Dyspareunie :**
 - Profonde.
 - Postérieure (atteinte des ligaments Utéro-Sacrés / Torus).
 - Majorée de façon cyclique et **positionnelle**.
3. **Dysurie :** Souvent associée à une pollakiurie.
4. **Dyschésie :** Douleur à la défécation (atteinte rectale).
5. **Douleurs pelviennes CHroniques (Dlr ch) :**
 - Installation progressive insidieuse, parfois quasi-permanente.
 - Types : Décharge électrique, crampes, brûlures, coup de poignard.
 - Irradiations : Cuisse, lombaires (signes neuropathiques).

Autres localisations: douleur vulvaire ou périnéale ou sur cicatrice de laparotomie, douleur ombilicale.

Saignements Génitaux (Adénomyose)

- **Mécanisme :** Les diverticules augmentent de volume, dissocient les fibres musculaires, gênant leur contraction hémostatique.
- **Signes :**
 - **Ménorragies :** Très fréquentes (60% des cas). S'aggravent avec le temps.
 - Saignotements (Spotting) péri-ovulatoires et prémenstruels.
 - Rarement métrorragies (sauf si nodules vaginaux).

Infertilité

- Concerne **50%** des cas.
- **Causes multifactorielles :** Inflammation pelvienne (macrophages, cytokines), altération ovocytaire, iron overload (surcharge en fer toxique), réceptivité endométriale altérée, dyspareunie (diminution fréquence rapports).

Autres Signes Évocateurs

- Hématurie, Hémoptysie (cataméniale), toux cyclique.

- Sciatalgie.
- Rectorragie.
- Douleur à la pointe de l'omoplate (Endométriose diaphragmatique).
- Gonflement + Douleur à une cicatrice.

Comorbidités et Syndromes Associés

- Syndrome de fatigue chronique (insomnie, dépression).
- Migraine.
- Mélanome ++.
- Allergies, Thyroïdite.
- Syndrome de l'intestin irritable (SII).
- Discrète augmentation risque cancer (sein, ovaire, thyroïde).

Examen Clinique

A réaliser de préférence en **période menstruelle +++**.

- **Spéculum** : Nodules bleuâtres (col, vagin), inspection des culs-de-sac (CDS) vaginaux et cicatrice d'épisiotomie.
- **Toucher Vaginal (TV)** :
 - Utérus rétroversé fixé (adhérences).
 - Taille utérus augmentée (si Adénomyose).
 - Douleur à la mobilisation utérine.
 - Rigidité des culs-de-sac vaginaux.
 - Annexe sensible ou masse ovarienne (Endométriome), fixité ?
- **Toucher Rectal (TR)** :
 - Noyaux douloureux infiltrant le Douglas (surtout ligaments Utéro-Sacrés fibrosés).
- **TR + TV combinés** : Nodules de la cloison recto-vaginale.
- **Examen général** : Omphalite, cicatrices de laparotomie/cœlioscopie, pulmonaire.

Examens paracliniques:

Toujours réalisés par des **radiologues experts +++**

Échographie Pelvienne (Endovaginale + Sus-pubienne)

- **1ère intention +++** (IRM si patiente vierge).
- **Conditions** : Vessie semi-pleine, en dehors des menstruations (pour éviter douleur + dysménorrhée limite l'évaluation de la mobilité des organes).
- Endovaginale+++ : Facilite la détection des foyers car réveille la douleur élective (pression douce mais précise sur des zones spécifiques ...).
- **Performance** : Spécificité 90% (opérateur dépendant).
- **Cartographie complète nécessaire.**

Signes Échographiques:

- **Adénomyose (Critères MUSA)** :
 - **Utérus globuleux** : L'utérus perd sa forme de poire pour devenir rond et volumineux.
 - **Asymétrie des murs utérins**: Une paroi du myomètre (souvent la postérieure) est nettement plus épaisse que l'autre.
 - **Kystes myométriaux (image anéchogène)**: Présence de petites poches de sang (+/- hypertrophie du stroma adjacent).
 - **Îlots hyperéchogènes**: Petites taches blanches brillantes correspondant à des fragments d'endomètre.
 - **Lignes ou bourgeons sous-endométriaux** : Stries linéaires verticales fines hyperéchogènes partant de l'endomètre et s'enfonçant dans le muscle.

- **Ombres en "éventail" (Fan-shaped shadowing) :** Des ombres linéaires verticales qui partent du myomètre.
- **Irrégularité ou interruption de la jonction endomètre-myomètre (JZ).**
- **Vascularisation trans-lésionnelle.**
- **Endométriome Ovarien :**
 - Kystes uniloculaires.
 - Contenu liquidien homogène finement échogène "**en verre dépoli**".
 - La présence de sang de différents âges
Le sang vieilli et dégradé (hémossidérine) ce qui crée de multiples petits échos de diffusion à l'intérieur du kyste. C'est pathognomonique.
 - Paroi souvent non vascularisée.
 - *Note:* Aspect modifié par grossesse (décidualisation: plus de cloisons et dans certain cas des papilles vascularisés).
 - *Signe de gravité :* "Kissing ovaries" (adhérences des deux ovaires l'un contre l'autre derrière l'utérus).
- **Endométriose Profonde (DIE) :**
 - Endovaginale vessie semi-remplie + préparation digestive et produit de contraste rectal pour l'atteinte digestive
 - Recherche atteinte vésicale, urétérale (dilatation pyélocalicielle), digestive (rectum), Torus , utérosacrés +++
 - **Nodule :** Image hypoéchogène spiculée, parfois punctums hyperéchogènes au centre, peu vascularisée.
 - On recherche en mobilisant l'utérus, des adhérences avec la face antérieure du rectum en arrière.
 - Recherche d'un nodule rectal + éventuelle extension à la musculuse.
 - Signe du glissement (Sliding sign) : Recherche d'adhérences utérus/rectum.

IRM Pelvienne

- **Indications :**
 - Supérieur à l'écho si échographiste non expert.
 - Diagnostic d'endométriose profonde, endométriome infracentimétrique.
 - Bilan pré-opératoire (degré d'infiltration pour choix TTT).
 - Distinction adénomyose externe / classique.
- **Technique :** Vessie semi-remplie, balisage vaginal et rectal (gel).
Sensibilité/Spécificité +++.
- **Limites :** Faux négatifs pour l'endométriose péritonéale superficielle
- **Signes :**
 - **Endométriome :** HyperT1, "Shading" en T2 (assombrissement dû au fer).
 - **Adénomyose :** Épaississement zone jonctionnelle > 12mm, spots hyperT1 (micro-hémorragies).

Autres Examens (3ème intention)

Si clinique mais Echo + IRM normales :

- **Écho-Endoscopie Rectale (EER) :** Pour localisations recto-sigmoïdiennes.
- **Colo-Scanner (Colo-CT) :** Pour le côlon.

Cœlioscopie

- **N'est plus obligatoire pour le diagnostic.** L'histologie n'est plus obligatoire +++.
Lorsque l'imagerie objective une endométriose: pas lieu de réaliser cœlioscopie à visée dgc.

- **Indications :**
 - Suspicion clinique forte avec imagerie négative (Test thérapeutique possible avant).
 - Si imagerie négative et pas de réponse au TTT
 - Dans le cadre d'une **stratégie de traitement** (douleur ou infertilité).
- **Aspects visuels :** Lésions bleuâtres, rouges ("rouges et noires"), blanches en étoiles, adhérences, saignement.
- **Action :** Description exhaustive (scores), biopsies dirigées si doute (Anapath négative n'exclut pas le diagnostic), traitement chirurgical.
Utiliser des classifications lésionnelles pour décrire l'étendue de l'endométriose et faciliter les échanges interprofessionnels

Hystéroscopie (si Adénomyose)

- Signes inconstants +++.
- Petits orifices punctiformes (canaux diverticulaires)
- Nodules bleuâtres
- Ectasie préostiale
- Aspect en colonnes (hypertrophie myométriale).

Démarche diagnostic:

L'approche moderne : **diagnostic clinique-radiologique**

- **Radiologie de 1 ère intention:** échographie pelvienne .
- **Radiologie de 2 ème intention:** Si signes orientateurs d'endométriose profonde, infertilité, endométriome (échographie par un échographiste référent ou IRM).
- **Radiologie de 3ème intention:** Si signes cliniques + echo + IRM normale
 - Une échoendoscopie rectale (EER) : localisations recto-sigmoïdienne
 - Un colo-scanner (colo-CT): colon

Stadification:

Classifications multiples et complexes.

Classification rASRM (classification révisée American Society for Reproductive Medicine)

- Stades I (minime) à IV (sévère).
- Basée sur des points (taille lésions, adhérences).
- **Limites :** Destinée à l'infertilité, ne reflète pas la douleur, ignore l'Endométriose Profonde et l'Adénomyose.
- De moins en moins utilisée moins reproductible et peu corrélée à la fertilité potentielle

Classification ENZIAN (IRM et Chirurgie)

- Spécifique pour l'**Endométriose Profonde (DIE)**.
L'IRM est corrélée au score ENZIAN chirurgical et est très précise dans la détection la localisation de l'Endométriose profonde.
- Corrélation significative avec la **l'étendue de la maladie, la difficulté et la durée de l'intervention** et la **sévérité des symptômes**.
- Décrit 3 compartiments (A: Recto-vaginal, B: Utérosacré/Latéral, C: Rectum) et la sévérité (1: <1cm, 2: 1-3cm, 3: >3cm).
- Suffixes pour autres atteintes : FA (Adénomyose), FB (Vessie), FU (Uretere), FI (Intestin), FO (Autres).
- Une stadification préopératoire correcte.
Mais encore peu utilisée par les praticiens

Prise en charge:

Principes Généraux:

- **Par qui ?** Multidisciplinaire (Gynéco, PMA, Viscéraliste, Urologue, Psychologue, Algologue).
- **Centre expert / RCP** (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) ++++.
- **Buts** : Soulager les algies, gérer les saignements, optimiser la fertilité, prévenir les récides, améliorer la Qualité de Vie.
- **Moyens** : TTT médical (Douleur, Saignement), Chirurgie, PMA.

Traitement Médical (symptomatique):

Il n'existe aucun traitement médical curatif qui fait disparaître la maladie !!! Il est suspensif.

Traitement symptomatique qui agit sur la **douleur et le saignement** mais pas sur l'infertilité.

Antidouleurs

- **AINS (Anti-inflammatoires non stéroïdiens)** :
 - **Mécanisme** : Inhibition cyclo-oxygénase (baisse synthèse prostaglandines).
 - **Indication** : Première intention si **dysménorrhée modérée isolée**. Efficacité similaire sur algies cycliques et non cycliques.
 - Protocole: **Ibuprofène 200/400mg** ou **Acide Méfénamique 1cp x3/j** (Dès le début des règles ou 2-3j avant, pendant 48-72h).
- **Douleur Neuropathique (Central sensitization)** :
 - Consultations antidouleur
 - Neurontin (Gabapentine), Laroxyl, Lyrica.
 - Approches corporelles (Ostéopathie, acupuncture, yoga) et corticales (méditation, sophrologie) => Efficaces à titre individuel

Traitement Hormonal (L'hormonothérapie)

Viser l'aménorrhée (suppression des règles).

Contraception Oestro-Progestative (COC = contraception orale combinée) :

- **Type** : Monophasique de 2ème génération (15-30 γ d'éthinylestradiol).
- **Mode de prise** : Continu (sans interruption, jeter les placebos) ou Cyclique.
- **Action** : Inhibe la production d'œstrogènes ovariens.
- **Gestion des saignements (Spotting)** : Si métrorragies sous prise continue > quelques mois, faire une fenêtre d'arrêt de 7 jours.
- Diminue la douleur
- Risque thromboembolique, age, risque cardiovasculaire

Progestatifs :

Le Diénogest (Visanne):

- **Classe** : Progestatif hybride.
- **Environnement hormonal créé** : Hypo-œstrogénique et Hyper-progestéronique.
- **Efficacité** : Aussi efficace que les GnRHa (analogues GnRH) sur les scores de douleurs et la qualité de vie.
- **Résultats** : Apparaissent entre 3 et 6 mois.
Persistance de la réduction des douleurs à 12 mois après l'arrêt.
- **Posologie** : 1 comprimé de **2 mg / jour** en continu.
- **Effets secondaires** : Métrorragie + Céphalées.
- **Contraception** : L'ovulation est complètement supprimée, mais l'effet contraceptif n'est pas sûr à 100% (attention si pas de désir de grossesse : ajouter une méthode barrière).
- **Indication** : Nouvellement indiqué dans l'endométriose.

Le Système Intra-Utérin (SIU) au Lévonorgestrel 52 mg (Mirena)

- **Mécanisme** : Entraîne une atrophie de l'endomètre par **décidualisation**.
- **Indications** : Dysménorrhée, douleurs pelviennes cycliques, ménorragies, dyspareunies.
- **Efficacité** :
 - Entraîne une aménorrhée chez **60 %** des patientes.
 - Réduction marquée du volume utérin de **10 à 23 %** après un an (intéressant pour l'adénomyose).
- **Risque majeur** : Risque d'expulsion (+++) si hypertrophie utérine importante.
 - *Stratégie* : Possibilité de mettre sous GnRH-a pendant quelques mois avant la pose si l'utérus est de grande taille.
- **Effets secondaires** : Dépression, acné, maux de tête, prise de poids, sensibilité mammaire, **kystes ovariens** (attention si syndrome prémenstruel).

Les Macroprogestatifs

- **Molécules** : Acétate de chlormadinone, médrogestone, acétate de nomégestrol, acétate de cyprotérone.
- **Propriété** : Effet antigonadotrope puissant.
- **Usage** : Très prescrits mais études anciennes. Efficaces en schéma continu.
- **Effets secondaires** : Prise de poids (7 à 10 % des patientes), cutanés (acné, sécheresse), saignements, perte des cheveux, diminution de la libido.
- Risque de **méningiome**. Nécessite un suivi par **IRM**.

DMPA (Progestatif retard)

- **Nature** : Dérivé de la 17-hydroxyprogestérone.
- **Efficacité** : Antigonadotrope. Efficace dans 80 à 90 % des cas (dysménorrhées, dyspareunies, douleurs pelviennes chroniques).
- **Maintien des effets** : Jusqu'à 6 mois après la fin des traitements.
- **Utilisation limitée car effets secondaires importants** :
 - Mêmes effets secondaires que les macroprogestatifs.
 - Effets androgéniques.
 - Délai de reprise de l'ovulation prolongé.
 - Utilisation à long terme : **Altération de la DMO (Densité Minérale Osseuse) possible**.

Le Danazol

- **Nature** : Dérivé de l'éthinyl-testostérone.
- **Action** : Antigonadotrope puissante (inhibe la synthèse des gonadotrophines).
- **Efficacité** : Efficace, entraîne une aménorrhée après 6 semaines.
- **Effets secondaires (Limitant son usage)** :
 - Acné et peau grasse, prise de poids, atrophie mammaire.
 - Raucité de la voix, myalgies, métorragies, bouffées de chaleur.
 - Hirsutisme, virilisme (rarement).
- Peu utilisé actuellement
- La voie vaginale diminue les effets secondaires.

Agonistes de la GnRH (GnRHa - Décapeptyl/Enantone) :

- **Action** : Provoquent une **ménopause chimique**.
- **Efficacité Clinique** :
 - Diminue la douleur de 3 à 6 points (sur EVA) en 10 mois.
 - Diminue la taille des lésions et de l'utérus.

- Efficace sur les ménorragies.
- **Molécule / Posologie** : Triptoréline 3mg/28 jours ou 11.25 mg/3 mois.
- **Durée du traitement** : Pas d'études au-delà de **12 mois**.
- **Add-back thérapie (Obligatoire)** :
 - Ajout de **1 mg de 17b-estradiol**.
 - *But* : Compenser la perte osseuse et les signes d'hypo-œstrogénie (bouffées de chaleur).
- **Contre-Indication** : Adolescente (croissance osseuse).

Nouveaux traitements :

Antagonistes GnRH

Inhibiteurs de l'aromatase.

Remarque: Agonistes GnRHa vs Antagonistes

- **Agonistes (GnRHa)** : Provoquent d'abord une stimulation ("Flare-up effect") avant de désensibiliser l'hypophyse (down-regulation), stoppant la production de FSH/LH.
- **Antagonistes** : Bloquent immédiatement les récepteurs GnRH sans effet "Flare-up". Action plus rapide.

Traitements Non-Chirurgicaux (Adénomyose):

- **Thermodestruction** : Semble meilleure que l'endométréctomie. Agit sur lésions profondes.
- **HIFU (Ultrasons focalisés)** : Nouvelle technique. Contre-indiqué si désir de fertilité.
- **Embolisation des artères utérines** : Amélioration 70% à 5 ans. **CI si désir de grossesse.**

Chirurgie

Doit être faite par un **expert**.

Risque de chirurgie itérative si incomplète.

Suivie d'un TTT médical post-opératoire si pas de désir de grossesse (diminue récidence).

Doit être complète, au bon moment et une seule fois dans la vie.

Chirurgie de l'Adénomyose

- **Chirurgie conservatrice (si adénomyose focale)** :
 - Endométréctomie hystéroscopique.
 - Adénomyomectomie (ablation du nodule d'adénomyose).
- **Chirurgie radicale** : Hystérectomie totale.

Chirurgie de l'Endométriose Externe

- **Chirurgie conservatrice:**
 - Technique privilégiée : Cœlio-chirurgie.
 - **Gestes sur lésions superficielles** : Destruction par coagulation bipolaire ou laser CO2.
 - **Gestes sur endométriose profonde** : Résection des noyaux d'endométriose. Chirurgie difficile (pas de plan de clivage avec les tissus avoisinants).
 - **Geste essentiel** : Le **Nerve-sparing** (respect des plexus nerveux). Cela prévient les séquelles urologiques post-opératoires (notamment la rétention urinaire).
 - **Autres gestes possibles** : Résection anastomose digestives, urétérale...
 - **But** : Rétablir les conditions anatomiques les plus proches possibles de la normale et les plus favorables à la fécondation.
 - **Post-opératoire** : TTT médical si pas de désir de grossesse +++.
- **Chirurgie radicale:**
 - Hystérectomie totale + annexectomie bilatérales + enlever le maximum des lésions

- La castration supprime les hormones ovariennes et entraîne la régression des lésions restantes.

Chirurgie de l'Endométriose

- **Voie :** Coelioscopie.
- **Techniques :**
 - Kystectomie (ablation du kyste).
 - Vaporisation au laser.
- Attention chez la femme jeune et/ou infertile. La kystectomie entraîne une **baisse de la réserve ovarienne** (+++).

Stratégie thérapeutique:

RCP

Situation 1 : Douleur SANS infertilité ni désir immédiat de grossesse

1. **1ère ligne :** Diénogest, COP (continu), autres progestatifs.
2. **2ème ligne :** Agonistes GnRH (+ Add-back therapy).
 - **Succès:** Garder le TTT au long court
 - **Échec médical :** Chirurgie conservatrice (ou radicale si plus désir de grossesse).
3. **Post-op :** TTT médical de maintenance +++.

Situation 2 : Désir de Grossesse

- **Place de la Chirurgie :**
 - Elle améliore la fertilité surtout dans l'année suivante.
 - Elle doit être réalisée **au bon moment et une fois dans la vie** (+++).
- **Risques de la chirurgie :**
 - Baisse de la réserve ovarienne si endométriose.
 - Complications.
 - Chirurgie difficile en cas d'adénomyose.
- **Indication chirurgicale :** Indiquée si l'endométriose est légère et si l'on pense que la fertilité peut être rétablie par chirurgie seule (sans PMA).

Préservation de la Fertilité (Avant la chirurgie):

- A envisager **Avant chirurgie** surtout:
- Si chirurgie itérative (répétée).
- Si endométrioses bilatéraux.
- Si endométriose récidivant.
- Si endométriose > 5 cm.
- Si risque de baisse de réserve ovarienne.